Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Panambi

Rua Júlio de Castilhos, 1183, 2ª Vara Judicial - Bairro: Nossa Senhora de Fátima - CEP: 98280-000 - Fone: (55)99727-0312 - www.tjrs.jus.br - Email: frpanambi2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002086-08.2023.8.21.0060/RS

AUTOR: DILVA MIRIAM FREES

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

DILVA MIRIAM FREES ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face de IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL. Narrou, em síntese, que é portadora de NEOPLASIA DE MAMA RECEPTOR HORMONAL POSITIVO (CID C50), com tumor inicial de 3,0 e que foi submetida a tratamento quimioterápico neoadjuvante e posterior cirurgia. Devido à neoplasia de mama de alto risco, o médico da autora indicou tratamento hormonal com os medicamentos ANASTRAZOL 1mg ao dia por 10 anos, associado ao ABEMICICLIBE 150mg, duas vezes ao dia, por um período de 02 anos contínuos, cujo valor do tratamento importa em R$ 28.468,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) por mês, conforme menor orçamento apresentado. Disse ter postulado pelo fornecimento do medicamento na via administrativa, entretanto, obteve a seguinte resposta negativa: ***"não estão previstos nas atuais recomendações técnicas em oncologia do Ipê-Saúde."***. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda, Requerendo, então, em sede de tutela de urgência, que o réu fornecesse imediatamente e integralmente a quantidade mensal necessária do medicamento "ANASTRAZOL 1mg e ABEMICICLIBE 150mg", sob pena de bloqueio de valores. No mérito, postulou pela procedência dos pedidos, com a confirmação da liminar e condenação da parte ré ao fornecimento dos medicamentos necessário ao seu tratamento, enquanto houver necessidade. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Juntou documentos (evento 1.2-13).

A análise da tutela de urgência foi relegada para momento posterior à avaliação e orientação pela equipe técnica do sistema e-NatjJus (evento 4, DESPADEC1).

Sobreveio emenda da inicial com novo pedido de análise do pedido liminar (evento 7, EMENDAINIC1).

A nota técnica foi devolvida pelo e-Natjus sob a alegação de que "Não se trata de ação em desfavor do SUS" (evento 21, EMAIL1).

O pedido liminar foi deferido no evento 23, DESPADEC1, oportunidade em que foi determinada a citação do requerido e deferida a gratuidade da justiça ao requerente.

Intimado para cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a parte ré comprovou o fornecimento do tratamento com os medicamentos indicados (evento 27, EMAIL3).

A parte ré apresentou contestação (evento 34, CONT1). Aduziu, em síntese, que a demanda não merecia prosperar porque a parte requerida não poderia ser compelida ao fornecimento de tratamento não coberto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Comentou acerca da afronta ao princípio da isonomia em razão da ausência de correspondência entre fonte de custeio e o tratamento requerido pelo autor. Salientou que a pretensão deduzida na inicial é ilegal, em razão da ausência de cobertura específica para o tratamento no regulamento do plano. Salientou a inaplicabilidade das disposições do CDC ao caso concreto, considerando a natureza pública do plano de saúde requerido. Expôs, com base na Lei Estadual nº 14.634/2014, ser isenta ao pagamento da taxa única dos serviços judiciais. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos. Juntou documento (evento 34, OFIC2).

A parte autora apresentou réplica (evento 39, RÉPLICA1).

A parte ré dispensou a produção de outras provas (evento 44, PET1). A autora, devidamente intimada, quedou-se silente (Ev. 41)

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

O feito transcorreu normalmente e não há nulidades a serem sanadas.

Assim, inexistindo preliminares a serem analisadas, presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, bem como não havendo outras questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito.

1. Da relação de consumo.

A relação mantida entre as partes é de consumo, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 2º e 3º, § 2º, e 17, todos do CDC.

Da mesma forma, a questão resta expressamente solvida pela súmula n. 469 do STJ:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Afasto, ainda, qualquer alegação de violação à isonomia conforme alegado pelo réu, pois a demandante contribui para o plano e merece receber os benefícios tanto quantos demais segurados.

Há de se pontuar porém, que, não obstante se trate de relação de consumo, e mesmo se admitida a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), é do consumidor o ônus de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

2. Da obrigação de fornecimento de medicamentos não incluídos em tabelas próprias do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL.

No caso, da análise dos documentos constantes nos autos, reputo ter restado demonstrado o direito pleiteado pela autora.

A Lei Complementar Estadual 12.134/2004, que dispõe sobre o IPE-SAÚDE, no § 1º do art. 1º prevê que:

Art. 1º - Fica reestruturado o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, denominado IPE-SAÚDE, tendo como gestor o IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, autarquia criada pelo DECRETO Nº 4.842, de 8 de agosto de 1931, segundo os ditames da presente Lei Complementar, resoluções e regulamentos próprios.

*§ 1º - O Sistema de que trata o "caput" engloba um conjunto de ações visando à prevenção de doenças, à promoção, educação e assistência à saúde de seus usuários, **constituído pelo Plano Principal, também denominado IPE-SAÚDE e por Planos Suplementares e Complementares**, que já existam ou que venham a ser criados, para o aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade da cobertura prestada. Ainda, o art. 2º da aludida Lei estabelece que "Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao tratamento, com ações de prevenção de doença e à promoção da saúde." - grifei.*

Além disso, o art. 2º da aludida da Lei Complementar dispõe que:

*"Art. 2. Integram o plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, **os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento**, bem como de ações de prevenção da doença." - grifei.*

Por sua vez, preceituam os artigos 8º e 9º da Resolução nº 21/79 do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul:

"Art. 8º. O Plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.

§ 1º. O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa, sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos." - grifei.

"Art. 9º. A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:

1 - Emergências;

2 - Consultas Médicas

3 - Serviços Complementares

4 - Tratamento Ambulatorial

5 - Tratamento hospitalar"

No caso concreto, a parte demandante pleiteia, em razão da negativa da parte ré, a determinação para que esta arque com o custo dos medicamentos ANASTRAZOL 1mg ao dia por 10 anos, associado ao ABEMICICLIBE 150mg, duas vezes ao dia, por um período de 02 anos contínuos, cujo valor do tratamento importa em R$ 28.468,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) por mês, afirmando a necessidade de urgência na realização do tratamento.

A necessidade e a urgência na utilização do fármaco estão comprovadas pelos exames e laudos médicos anexos aos autos nos eventos evento 1, LAUDO7, evento 1, RECEIT8 e evento 1, RECEIT9.

A negativa administrativa pelo plano de saúde se deu sob argumentação de que ***não estão previstos nas atuais recomendações técnicas em oncologia do Ipê-Saúde.***.

Entretanto, não há razoabilidade para a negativa de fornecimento do tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente e postulado pela parte autora ao IPE-SAÚDE, porquanto a Lei Complementar Estadual nº 12.134/2004 e a Resolução nº 21/79 preveem que serão cobertos pelo IPE-SAÚDE todos os "atos necessários ao tratamento".

Nesse sentido:

*"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. **BENEFICIÁRIO DO PLANO IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COBERTURA DEVIDA**. TAXA ÚNICA. ISENÇÃO. 1. **Não deve ser tolhido o direito da parte autora de ter custeado pelo IPE-SAÚDE o tratamento médico completo que necessita, com os medicamentos indicados pelo médico assistente, porquanto a Lei Complementar Estadual nº 12.134/2004 e a Resolução nº 21/79 preveem que serão cobertos pelo IPE-SAÚDE os atos necessários ao tratamento**. 2. O médico que acompanha o paciente é quem possuiu competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do paciente já fragilizado pela doença, que não pode sujeitar-se aos entraves internos adotados pela administração, pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico adequado. 3. Demanda ajuizada quando já em vigor a Lei Estadual nº 14.634/14, estando isento o IPERGS do pagamento da Taxa Única de Serviços*

*Judiciais. 4. A isenção do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais não exime a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações da **obrigação** de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70079975850, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 05/12/2018).".*

Para além disso, não há nenhuma referência expressa de exclusão de cobertura acerca do medicamento necessário ao tratamento da autora. Além do mais, firmou-se, na Jurisprudência, a compreensão de que o critério que define a cobertura dos serviços de tratamento hospitalar no âmbito do IPE SAÚDE é o de exclusão expressa, isto é, o segurado tem direito a todos os atos necessários para o tratamento de sua saúde, salvo expressa vedação administrativa.

Cito, por oportuno, o seguinte precedente em caso análogo em que foi requerido especificamente o mesmo medicamento postulado pelo autor nestes autos:

> *IPE-SAÚDE. **MEDICAMENTO**. PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA AUTOIMUNE. ELTROMBOPAQUE **OLAMINA**. ARTS. 1º E 2º, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.134/04. RESOLUÇÃO Nº 27/1979, ARTS. 8º E 9º. **Abrangendo a cobertura do tratamento de** saúde **mantido pelo** IPE-Saúde**, tal como prevista pela Lei Complementar Estadual nº 12.134/04, arts. 1º e 2º, e Resolução nº 27/1979, arts. 8º e 9º, o tratamento hematológico e imunológico, é de ser mantida sentença que determinou ao IPERGS o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico conveniado, indicado ao tratamento medicamentoso**. POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. IPE-SAÚDE. Comprovada a cisão do IPERGS em IPÊ-SAÚDE e IPÊ-PREVIDÊNCIA, cabível a alteração do polo passivo pleiteada, para que nele figure IPE-SAÚDE, a teor das Leis Complementares Estaduais nºs 144/2018 e 145/2018.(Apelação Cível, Nº 70081052102, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 24-04-2019) - grifei.*

Logo, o direito da parte autora de receber a medicação está amparado por lei, de modo que a procedência da ação é medida impositiva.

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **DILVA MIRIAM FREES** em face de **IPÊ-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela (**evento 23, DESPADEC1**), **CONDENAR** a parte ré ao fornecimento dos medicamentos **ANASTRAZOL 1mg ao dia associado ao ABEMICICLIBE 150mg,** na dosagem especificada nos receituários anexo aos autos nos eventos evento 1, RECEIT9 e evento 1, RECEIT9, ou outra dosagem que vier a ser solicitada por indicação médica, pelo prazo necessário ao tratamento, admitida a substituição pelo princípio ativo de acordo com a Denominação Comum Brasileira, desde não haja prejuízo ao tratamento da parte autora.

Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários do advogado da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º e 3º, do CPC, com correção monetária pelo IGP-M a contar desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, considerado o trabalho desempenhado, a natureza da demanda e a extensão da controvérsia.

Outrossim, com relação ao pagamento das custas processuais, a presente demanda foi proposta em 18.05.2023, razão por que deve ser aplicada a isenção concedida no art. 5º, inciso I, da Lei Estadual nº 14.634/2014[1], que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais e entrou em vigor no dia 15 de junho de 2015.

Há que se ressaltar, porém, que a isenção do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais não exime a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, fulcro art. 496, § 3º, inciso II, do CPC[2], considerando que a condenação possui valor líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Agendada intimação das partes via sistema E-proc.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **NATHALIA ALONSO E ALONSO BARREIROS, Juíza Substituta na Titularidade Plena**, em 27/2/2024, às 10:47:6, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10054619606v5** e o código CRC **d34b3cfd**.

---

1. Art. 5.º São isentos do pagamento da taxa:I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e asrespectivas autarquias e fundações; ↩
2. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:...§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:... II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; ↩